

Ein schulpflichtiges Kind in Ihrer Praxis

Für Hausärzt:innen, Pflegekräfte und Gesundheitsberufe — Versorgung eines autistischen Grundschulkindes (etwa 6–11 Jahre).

Die Kernidee

Autismus bedeutet über den **Monotropismus**, dass die Aufmerksamkeit eines Kindes jeweils in wenige tiefe, intensive „Tunnel“ eingeschlossen wird — lebendig innen, schwach außen und kostspielig zu wechseln. Schule ist oft der erste echte Stresstest: laut, visuell belebt und unvorhersehbar, entzieht die Aufmerksamkeit, die allem anderen zustehen sollte. Viele Kinder **halten sich in der Schule zusammen und brechen danach zusammen** — auch in Ihrem Wartezimmer. Mit dem Tunnel zu arbeiten, nicht gegen ihn, ist der Schlüssel.

Was Sie beobachten könnten — und was wirklich dahintersteckt

Sie könnten sehen...	Was oft tatsächlich passiert
„In der Schule gut“, Meltdowns oder Shutdowns zu Hause oder in der Praxis	Das Kind hat den ganzen Tag maskiert; Zuhause — und Ihre Praxis — ist, wo die Maske endlich fällt
Bauchweh, Kopfschmerzen, „isst nicht“; keine klare organische Ursache	Hohe sensorische und soziale Last zeigt sich über den Körper; auch häufig: GI- und Schlaf-Ko-Vorkommen
Schwierig zu beginnen, zu wechseln oder zu stoppen; wirkt „faul“ oder trotzig	Autistische Trägheit — die mentale Spur zu wechseln kostet echte Energie, keine Willenskraft
Plötzlich „verlorene“ Kompetenzen aus dem Vorjahr	Oft Burnout / eine Verlagerung der Aufmerksamkeitsressourcen unter Überlastung, keine echte Regression
Nimmt Dinge wörtlich; braucht Extrazeit zum Antworten	Eingekanalige, wörtliche Kommunikation + Verarbeitungszeit

Versuchen Sie dies

- **Senden Sie ein Vorab-Formular** (das AASPIRE AHAT, autismandhealth.org) und fragen Sie die Eltern, was hilft; heißen Sie Kopfhörer, Sonnenbrille und ein Trostobjekt willkommen.
- **Buchen Sie den ruhigsten Termin**, dimmen Sie das Licht, senken Sie Signaltöne; erlauben Sie eine vertraute Bezugsperson im Raum.
- **Erklären Sie jeden Schritt vor der Ausführung**, in kurzen wörtlichen Sätzen; lassen Sie das Kind stimmen oder ein Interessensobjekt festhalten.
- **Fragen Sie nach Schul-Last und Erholung**, nicht nur nach Symptomen — „Wie lange Erholung nach einem Schultag?“ kennzeichnet Überlastung.
- **Schaffen Sie gemeinsam eine einfache Gesundheitsroutine** (derselbe Raum, derselbe Ablauf) für Folgebesuche.

Vermeiden Sie dies

- Maskierte Fassung als „ihm geht’s gut“ behandeln oder einen Shutdown als Verweigerung.
- Lange verbale Anweisungen, Überraschungseingriffe oder „sei tapfer!“-Sätze.

- Härter drängen, wenn Kompetenzen gefallen sind — die evidenzbasierte Antwort auf Burnout ist **Anforderungen reduzieren und Ruhe und Interessen wiederherzustellen**.

Wann weitere Hilfe nötig ist

Achten Sie auf **autistisches Burnout** (chronische Erschöpfung, Kompetenzverlust, verminderte Reiztoleranz) — es ist *von Depression* und von gewöhnlichem Stress zu unterscheiden und wird durch Masking verschlimmert. Screenen Sie auf die häufigen Ko-Vorkommen: **Angst, ADHD (AuDHD), Schlaf- und GI-Probleme**. Fragen Sie direkt nach Schulbesuch und Mobbing. Verweisen Sie an Förderkoordination/SENCO-Unterstützung und autistisch geführte Eltern-Gruppen.

Wenn das Kind ein Mädchen ist

Mädchen in diesem Alter **masken stark** und werden häufig übersehen oder fehldiagnostiziert (Angst, „schüchtern“). Nehmen Sie elterliche Besorgnis ernst, auch wenn Lehrkräfte ein ruhiges, folgsames Kind sehen — die Kosten werden ungesehen gezahlt.

Über diesen Leitfaden

KI-gestützt, abgeleitet aus den Forschungsentwürfen dieses Projekts — das **Monotropismus**-Dossier und der Leitfaden für **Praktiker und Gesundheitsfachleute über die Lebensspanne** (Teile 3.2 & 4). Verwendet *identitätsfirst-Sprache*. **Information — kein medizinischer Rat und kein diagnostisches Werkzeug**. Passen Sie es an das einzelne Kind an.

Schlüsselquellen. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2019, *Monotropism at School*; 2023); Dwyer (2025); Edgar (2024, Regression/Burnout); Raymaker et al. (2020); AASPIRE AHAT; Kelly Mahler (2024). Vollständige Nachweise finden sich in den Quelldossiers.